DOCTOR INVEST · ESTUDO QUANTITATIVO

Não é a CBS

A CBS de 11,3% calculada pelo TCU mexe menos de um ponto no imposto de uma clínica médica. Na escolha entre Simples e lucro presumido, quem decide é a folha: o pró-labore que o Simples exige e os funcionários que a clínica tem. A partir de 2029 entra o fim do ISS.

CBS de 11,3% · TCU, 28/10/2026

Imposto contado até o CPF, com a Lei 15.270

1 e 2 sócios · com e sem equipe

2027 e 2033

Simulador para o seu caso

Doctor Invest · Gestão de investimentos e consultoria financeira para médicos · Hélio Cardoso de Barros, CGA · outubro de 2026

01

O que este estudo mede

Em 28 de outubro o TCU calculou a alíquota de referência da CBS de 2027 em 11,3%. Toda clínica médica faz a mesma pergunta: o lucro presumido ainda compensa, ou é hora de voltar ao Simples? Este estudo faz a conta inteira, da nota fiscal ao CPF do médico, para faturamentos de R$ 120 mil a R$ 4,8 mi por ano.

Cada regime entra no seu melhor desenho. No Simples, o motor compara o Anexo III, que exige pró-labore de 28% do faturamento, com o Anexo V, que aceita o pró-labore mínimo. No presumido, testa todos os pró-labores. A conta soma o tributo da empresa, o INSS, o IRPF do pró-labore e o IR mínimo que a Lei 15.270 cobra sobre os dividendos desde 2026.

−0,5 a −0,9 pt

É quanto o imposto total do presumido muda de 2026 para 2027 com a CBS de 11,3%, quando metade das compras gera crédito. Sem crédito nenhum, sobe de 0,1 a 0,3 ponto.

28%

O pró-labore que o Simples exige para a clínica ficar no Anexo III. Quem atende sozinho paga até 27,5% de IR sobre ele. A clínica com equipe chega a esse número com a folha.

+1,9 a +3,0 pt

É o que o IBS de 2033 acrescenta ao presumido, no lugar do ISS de 2%. No Simples de até R$ 3,6 milhões, nada muda.

1. **A CBS de 11,3% não decide nada em 2027.** A saúde paga 40% da alíquota: 4,52% por fora, ou 4,32% do que o paciente paga. É perto dos 3,65% de PIS e Cofins de hoje. Além disso, a CBS gera crédito nas compras e sai da base do IRPJ. Para o médico sozinho trocar de regime por causa dela, a alíquota teria de chegar a 15,0% ou mais.
2. **O médico sozinho, sem funcionários, só ganha no Simples até R$ 300 mil por ano.** Acima disso o presumido deixa mais dinheiro no bolso: R$ 40 mil a mais em R$ 900 mil e R$ 38 mil em R$ 1,2 milhão. O motivo é o Fator R: para ficar no Anexo III, o médico precisa tirar 28% do faturamento como pró-labore e pagar IR sobre isso.
3. **A clínica com equipe CLT fica melhor no Simples de R$ 120 mil a R$ 3,9 mi.** A folha dos funcionários entra no Fator R, o que reduz o pró-labore necessário. O INSS patronal dessa folha, de 27,8% no presumido, fica dentro do DAS. Em R$ 1,8 milhão, o Simples deixa R$ 59 mil a mais por ano.
4. **A equiparação hospitalar pesa mais que a reforma inteira.** Com presunção de 8% e 12%, o presumido ganha a partir de R$ 240 mil sem funcionários e de R$ 660 mil com equipe. Em R$ 1,2 milhão, a vantagem chega a R$ 98 mil por ano. A equiparação exige sociedade empresária, as normas da Anvisa e um serviço que não seja consulta.
5. **O IR mínimo da Lei 15.270 decide a faixa do meio a favor do Simples.** Em R$ 1,8 milhão, o médico sozinho no presumido paga R$ 126 mil de IR mínimo. No Anexo III, o IRPF do pró-labore já cobre o mínimo e sobram R$ 3 mil (Anexo III). Sem a Lei 15.270, o vencedor seria outro de R$ 1,3 mi a R$ 3,6 mi para o médico sozinho em 2033 e de R$ 2,2 mi a R$ 3,6 mi para a clínica com equipe em 2027. Dois sócios dividindo o lucro pagam menos: R$ 6 mil em R$ 1,8 milhão.
6. **Em 2033 a conta muda de lado em várias faixas.** O IBS no lugar do ISS soma 1,9 a 3,0 pontos ao presumido. Para o médico sozinho, o presumido só ganha de R$ 560 mil a R$ 1,2 mi e acima de R$ 3,6 mi. Quem escolhe o regime em 2027 precisa refazer a conta a partir de 2029, quando o ISS começa a sair.

02

Como a conta foi feita

Uma clínica em ano estável. O faturamento dos últimos doze meses é igual ao do ano, o lucro sai todo no próprio ano, em doze parcelas, e os sócios dividem igualmente. O paciente paga o mesmo valor nos dois regimes. No presumido de 2027 em diante, a CBS (e o IBS em 2033) é cobrada por fora e sai de dentro desse valor. Por isso a receita que serve de base ao IRPJ fica um pouco menor.

Dois perfis de custo. No médico enxuto, não há funcionários, e aluguel, material e serviços somam 15% do faturamento. Na clínica com equipe, a folha CLT (com 13º e férias) é de 15% e os outros custos são de 20%. Metade das compras gera crédito de CBS e IBS. Aluguel pago a pessoa física e serviço de quem está no Simples geram pouco ou nada, e a seção 09 mostra a conta com 0% e com 100%.

Cada regime no seu melhor desenho. O pró-labore mínimo é um salário mínimo por sócio (R$ 1.621,00). No Simples, o motor varre o pró-labore. Abaixo de 28% de folha sobre faturamento a clínica cai no Anexo V, e a partir daí, no Anexo III. O motor fica com o desenho que deixa mais dinheiro líquido aos sócios. No presumido, varre do mínimo para cima, e em nenhuma faixa subir o pró-labore compensou. O lucro é distribuído com escrituração contábil, que é o que permite distribuir isento acima da base presumida.

O que entra como imposto. DAS ou CBS, IBS e ISS; IRPJ e CSLL; INSS patronal sobre o pró-labore e a folha; INSS do sócio (11% até o teto de R$ 8.475,55); IRPF do pró-labore pela tabela de 2026, com o desconto da Lei 15.270; e o IR mínimo anual sobre a renda total do sócio, abatido do IR já pago. A retenção de 10% dos dividendos é antecipação do IR mínimo e aparece como dinheiro preso, não como imposto.

Duas janelas. Em 2027 vale a CBS cheia (a referência menos 0,1 ponto, mais 0,1% de IBS de teste), o PIS e a Cofins acabam e o ISS municipal segue inteiro. Em 2033 o ISS já não existe e o IBS está completo. 2026, com PIS e Cofins, entra só como régua para medir o efeito da CBS. As premissas foram registradas antes de o motor rodar; o arquivo está junto com a base.

QUATRO NÚMEROS AINDA NÃO SÃO DEFINITIVOS

A CBS de 11,3% é o cálculo do TCU. Quem fixa é o Senado, por resolução, até 15 de dezembro de 2026. Se o Senado não decidir, vale o número do TCU. A seção 05 mostra que a decisão de regime sobrevive a uma variação grande.

O IBS de 2033 não tem número oficial. O estudo usa 18,7%, a projeção do Comitê Gestor do IBS. Somado à CBS, dá 30% de alíquota cheia, e a saúde paga 12,0%. A seção 09 testa um IBS menor.

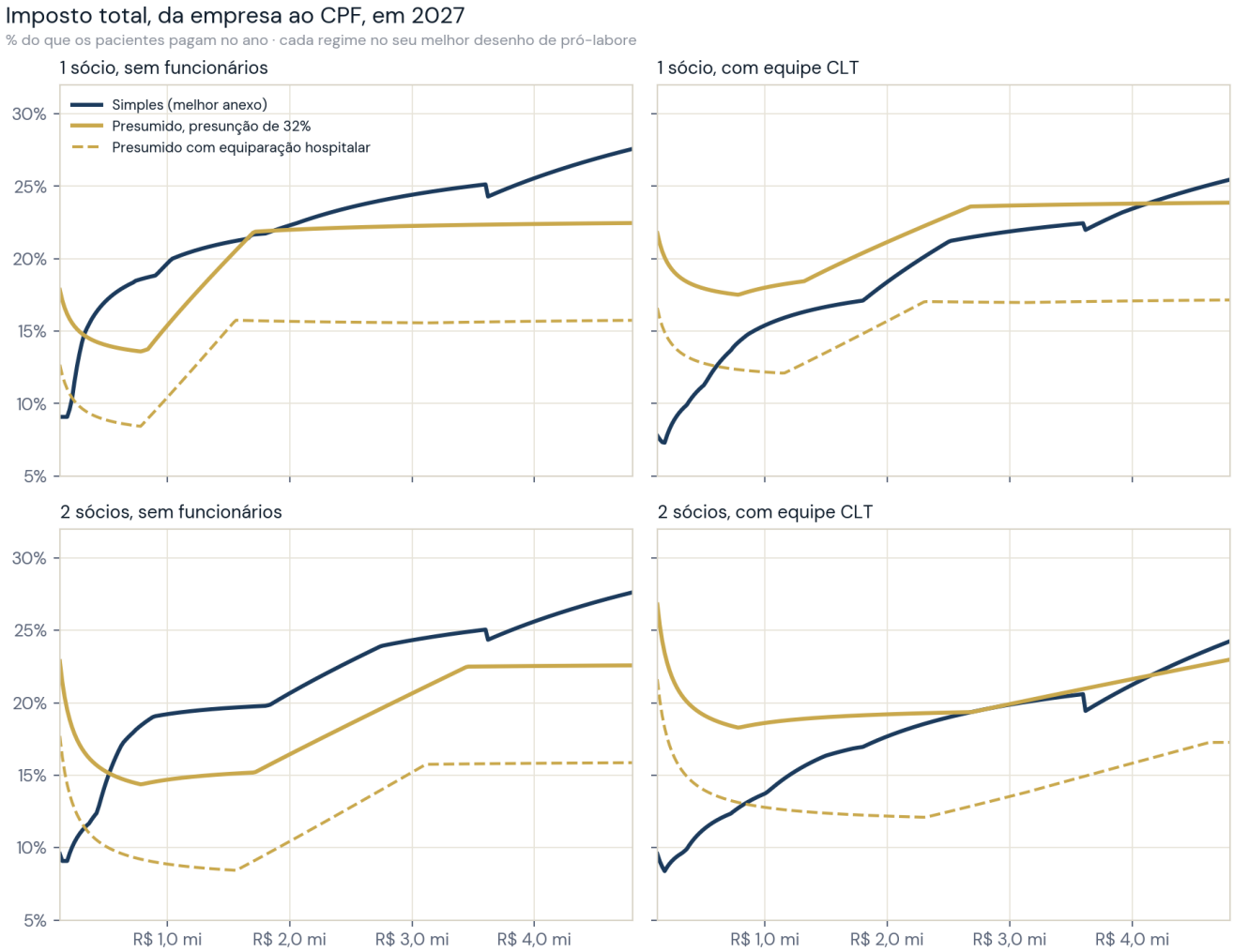
O redutor da Lei 15.270 ainda não tem regulamento. Ele só age quando o imposto da empresa somado ao IR mínimo passa de 34%. Isso não acontece em nenhum caso do estudo.

O IR mínimo sobre lucro do Simples. A lei não exclui esse lucro da base, e a Receita já aplica a ele a retenção de 10%. O estudo cobra o IR mínimo nos dois regimes.

03

Quem ganha, faixa por faixa

O gráfico mostra o imposto total como fatia do que os pacientes pagam, nos quatro tipos de clínica. A linha azul é o Simples no melhor anexo de cada faixa. As douradas são o presumido, com e sem equiparação hospitalar.



Imposto total em 2027 como % do faturamento. Cada ponto é o melhor desenho de pró-labore daquele regime, calculado de R$ 20.000 em R$ 20.000.

Presunção de 32%, em 2027

Faturamento por ano	R$ 240 mil	R$ 360 mil	R$ 600 mil	R$ 900 mil	R$ 1,2 mi	R$ 1,8 mi	R$ 2,4 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,8 mi
1 sócio, sem funcionários	**S-III** +9 mil	**LP** +4 mil	**LP** +24 mil	**LP** +40 mil	**LP** +38 mil	empate	**LP** +29 mil	**LP** +100 mil	**LP** +246 mil
1 sócio, com equipe CLT	**S-III** +26 mil	**S-III** +31 mil	**S-III** +31 mil	**S-III** +25 mil	**S-III** +27 mil	**S-III** +59 mil	**S-III** +47 mil	**S-III** +47 mil	**LP** +76 mil
2 sócios, sem funcionários	**S-III** +18 mil	**S-III** +16 mil	**LP** +11 mil	**LP** +41 mil	**LP** +54 mil	**LP** +76 mil	**LP** +104 mil	**LP** +92 mil	**LP** +242 mil
2 sócios, com equipe CLT	**S-III** +30 mil	**S-III** +37 mil	**S-III** +41 mil	**S-III** +46 mil	**S-III** +46 mil	**S-III** +39 mil	**S-III** +13 mil	empate	**LP** +61 mil

S-III e S-V: Simples no Anexo III ou V. LP: lucro presumido. Embaixo, quanto o vencedor deixa a mais no bolso dos sócios por ano. Empate é diferença menor que 0,5% do faturamento.

O dado que mais chama atenção é a distância entre as duas colunas da esquerda e as duas da direita. Com o mesmo faturamento, a clínica com equipe fica melhor no Simples, e o médico sozinho, no presumido. Sem funcionários, o Simples ganha de R$ 120 mil a R$ 300 mil e o presumido, de R$ 340 mil a R$ 1,6 mi e acima de R$ 2,1 mi. Com equipe, o Simples ganha de R$ 120 mil a R$ 3,9 mi.

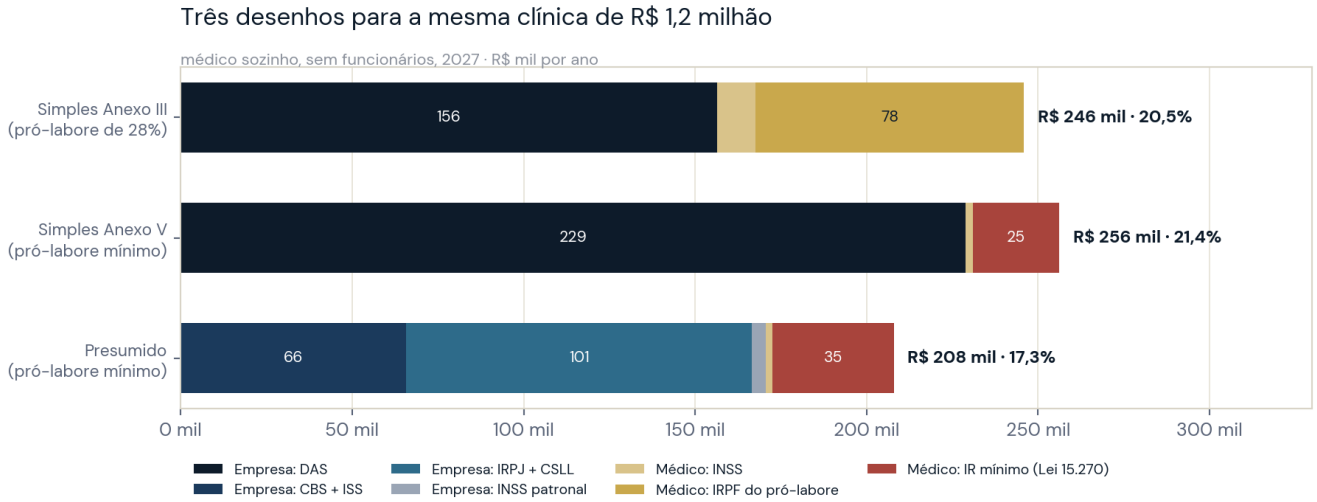
O Simples sobe em degraus. A tabela muda de alíquota em R$ 180 mil, R$ 360 mil, R$ 720 mil, R$ 1,8 milhão e R$ 3,6 milhões, e cada degrau mexe na disputa. Perto de R$ 1,8 milhão, o médico sozinho fica empatado nos dois regimes, porque a 4ª faixa do Anexo III termina ali. Acima de R$ 3,6 milhões, o ISS sai do DAS e a alíquota do Anexo III sobe depressa. Perto do teto de R$ 4,8 milhões, o Anexo V com pró-labore mínimo passa a ser o melhor Simples, e mesmo ele perde para o presumido.

04

O pró-labore que o Simples cobra

A diferença entre o médico sozinho e a clínica com equipe tem uma causa só: o Fator R.

O Simples tributa a medicina pelo Anexo III, que é barato, quando a folha dos últimos doze meses é de pelo menos 28% do faturamento. Abaixo disso, a clínica vai para o Anexo V, bem mais caro. Para quem atende sozinho, a única folha é o próprio pró-labore. Para ficar no Anexo III, ele precisa tirar 28% do faturamento como salário e pagar IRPF de até 27,5% sobre isso.



Médico sozinho, sem funcionários, R$ 1,2 milhão por ano, 2027. Os números dentro das barras estão em R$ mil.

R$ mil por ano	Pró-labore/ mês	Tributo da empresa	INSS + IRPF do pró-labore	IR mínimo	Imposto total	% do faturamento	Retido na fonte
Simples, Anexo III	28.000	156	90	0	**246**	20,5%	0
Simples, Anexo V	1.621	229	2	25	**256**	21,4%	77
Lucro presumido	1.621	171	2	35	**208**	17,3%	83

No Anexo III o DAS é de R$ 156 mil (13,0% do faturamento). Mas o pró-labore de R$ 28.000 por mês custa R$ 78 mil de IRPF no ano. No Anexo V o pró-labore é mínimo, mas o DAS sobe para R$ 229 mil (19,1%), e o lucro maior ainda paga R$ 25 mil de IR mínimo. O presumido cobra R$ 171 mil na empresa e R$ 35 mil de IR mínimo no CPF. No total são R$ 208 mil, contra R$ 246 mil e R$ 256 mil.

A VARIÁVEL ESCONDIDA

Na clínica com equipe, a folha de R$ 180 mil por ano já cumpre boa parte do Fator R, e o pró-labore necessário cai para R$ 11.800 por mês. Essa mesma folha custaria R$ 50 mil por ano de INSS patronal, RAT e terceiros no presumido, e no Simples isso está dentro do DAS. O regime certo depende de quem está na folha, não da alíquota de um tributo novo.

05

A CBS de 11,3%

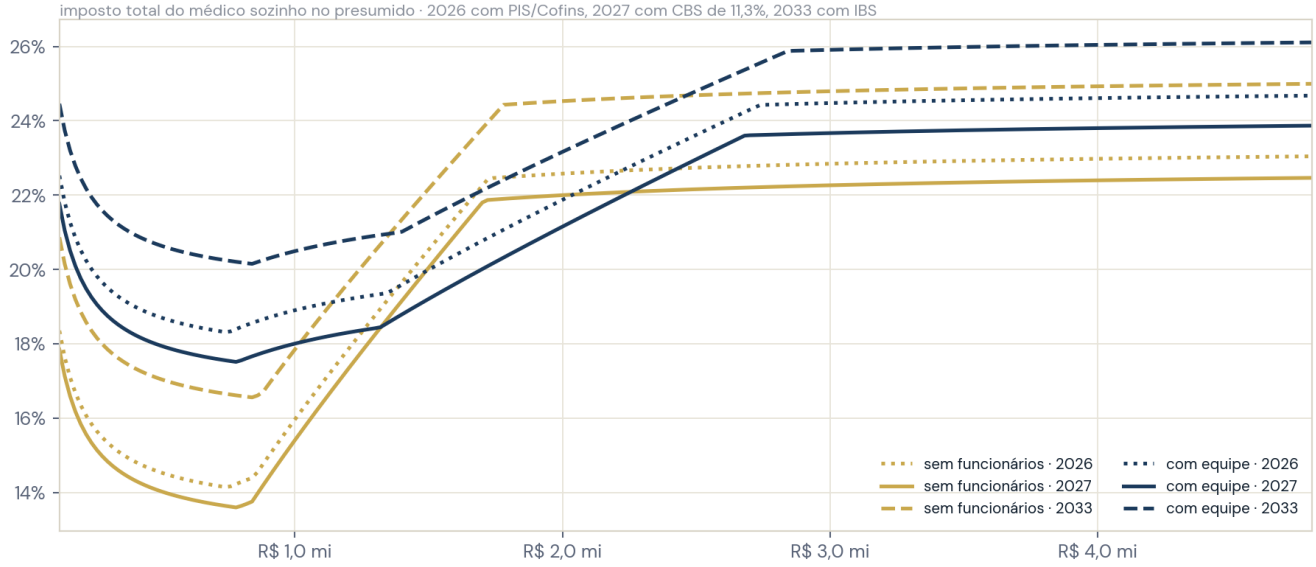
Parece um número grande. Para a clínica, ele vira 4,52%.

A lei da reforma dá 60% de redução de CBS e IBS aos serviços de saúde, e consulta e clínica médica estão na lista, sem exigência de forma societária. Em 2027 a clínica do presumido paga 4,52% por fora, o equivalente a 4,32% do que o paciente paga. O PIS e a Cofins cumulativos de hoje são 3,65%. A diferença é pequena, e dois

efeitos a compensam. A CBS dá crédito sobre as compras, coisa que o PIS e a Cofins cumulativos não davam. E, por ser cobrada por fora, ela sai da receita que serve de base ao IRPJ e à CSLL.

O presumido antes e depois da CBS

imposto total do médico sozinho no presumido · 2026 com PIS/Cofins, 2027 com CBS de 11,3%, 2033 com IBS



Imposto total do médico sozinho no presumido, % do faturamento. 2026 com PIS e Cofins; 2027 com a CBS de 11,3%; 2033 com CBS e IBS completos.

A linha cheia de 2027 fica abaixo da pontilhada de 2026 nos dois perfis. Com metade das compras gerando crédito, o presumido de 2027 sai 0,5 a 0,9 ponto mais barato que o de hoje. Sem crédito nenhum, sai 0,1 a 0,3 ponto mais caro. O salto de verdade é a linha tracejada: 2033.

Em que CBS o vencedor mudaria

Faturamento por ano	R$ 240 mil	R$ 360 mil	R$ 600 mil	R$ 900 mil	R$ 1,2 mi	R$ 1,8 mi	R$ 2,4 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,8 mi
1 sócio, sem funcionários	—	**15,0%**	**26,5%**	**31,4%**	**26,7%**	10,5%	**16,5%**	**23,5%**	**34,6%**
1 sócio, com equipe CLT	—	—	—	—	1,9%	—	0,2%	5,2%	**18,7%**
2 sócios, sem funcionários	—	—	**18,1%**	**29,6%**	**29,7%**	**29,8%**	**32,5%**	**22,5%**	**34,3%**
2 sócios, com equipe CLT	—	—	—	—	—	2,2%	9,0%	9,4%	**18,4%**

CBS cheia, antes da redução da saúde, em que Simples e presumido empatam em 2027. Em negrito, onde o presumido ganha hoje: o número é quanto a CBS teria de subir para o Simples passar a ganhar. Sem negrito, onde o Simples ganha: é quanto ela teria de cair para o presumido ganhar. Traço: entre 0% e 60% o vencedor não muda.

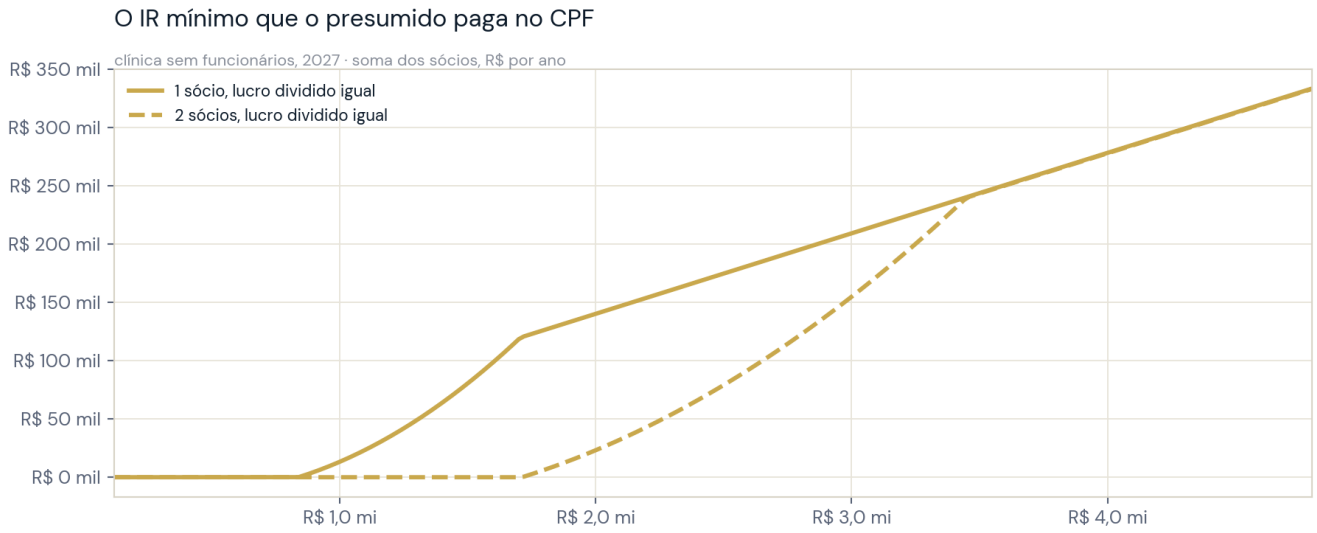
PRAZO: 30 DE OUTUBRO DE 2026

A clínica do Simples pode pedir para recolher CBS e IBS fora do DAS, pelo regime regular, a partir de janeiro de 2027. Pela Resolução CGSN 194/2026, o pedido vai até 30/10/2026 e o cancelamento, de 3/11 a 20/12. A opção serve a quem vende para empresa que aproveita crédito. O paciente pessoa física não aproveita, e a operadora de plano de saúde também não: ela abate da própria base o que paga ao prestador, qualquer que seja o regime dele. Para a clínica médica típica, a opção raramente compensa.

06

O IR mínimo e o dinheiro preso

Desde janeiro de 2026, o dividendo que passa de R$ 600 mil por ano para a mesma pessoa entra no IR mínimo. A alíquota vai de zero a 10% em R$ 1,2 milhão de renda total, e o IR que o sócio já pagou abate o valor. O presumido distribui quase todo o lucro como dividendo, por isso sente esse imposto primeiro. O Simples no Anexo III quase não sente: o IRPF do pró-labore de 28% já passa do mínimo.



IR mínimo da Lei 15.270 pago pelos sócios do presumido, clínica sem funcionários, 2027.

Em R$ 1,2 milhão o médico sozinho paga R$ 35 mil. Em R$ 1,8 milhão, R$ 126 mil, e em R$ 2,4 milhões, R$ 168 mil. Com dois sócios dividindo o lucro, cada um fica com metade da base: os valores caem para zero, R$ 6 mil e R$ 66 mil. Acima de R$ 3,6 milhões os dois sócios já estão na alíquota cheia, e a divisão deixa de ajudar. Esse imposto muda o vencedor numa parte da tabela da seção 03. Para a clínica com equipe, é ele que mantém o Simples na frente de R$ 2,2 mi a R$ 3,6 mi em 2027. Para o médico sozinho de 2033, é ele que traz o Simples de volta de R$ 1,3 mi a R$ 3,6 mi. A lógica é a mesma nos dois casos: o IR mínimo cobra de quem recebe dividendo e quase nada de quem já pagou IRPF sobre o pró-labore.

A retenção é outro problema. Quando a mesma empresa paga mais de R$ 50 mil de dividendos num mês à mesma pessoa, retém 10% sobre o total. Em R$ 1,2 milhão o médico sozinho tem R$ 83 mil retidos no ano, contra R$ 35 mil de IR mínimo devido. A diferença de R$ 48 mil volta só na declaração do ano seguinte, sem correção. Distribuir no máximo R$ 50 mil por mês e por sócio evita a retenção.

DIVIDIR COM UM SÓCIO

A divisão do lucro só se sustenta se o sócio de fato participa da clínica. Distribuição fora da proporção das quotas precisa estar prevista no contrato social. E, no casamento com separação de bens, o que vai para o cônjuge passa a ser dele. Essas são perguntas para o contador e o advogado, não para uma planilha.

07 · A CONCLUSÃO INCÔMODA

A equiparação pesa mais que a reforma

Nenhuma alíquota da reforma mexe tanto na conta quanto uma linha da lei do imposto de renda de 1995.

No lucro presumido, o serviço médico comum é tributado como se 32% da receita fossem lucro. Os serviços hospitalares e de apoio a diagnóstico e terapia usam 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Com isso, o imposto de renda da empresa cai a menos de um terço. A tabela abaixo refaz a disputa de 2027 com essa presunção.

Com equiparação hospitalar, em 2027

Faturamento por ano	R$ 240 mil	R$ 360 mil	R$ 600 mil	R$ 900 mil	R$ 1,2 mi	R$ 1,8 mi	R$ 2,4 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,8 mi
1 sócio, sem funcionários	**LP** +3 mil	**LP** +22 mil	**LP** +55 mil	**LP** +84 mil	**LP** +98 mil	**LP** +109 mil	**LP** +185 mil	**LP** +342 mil	**LP** +568 mil
1 sócio, com equipe CLT	**S-III** +13 mil	**S-III** +12 mil	empate	**LP** +25 mil	**LP** +45 mil	**LP** +41 mil	**LP** +87 mil	**LP** +195 mil	**LP** +399 mil
2 sócios, sem funcionários	**S-III** +6 mil	**LP** +2 mil	**LP** +42 mil	**LP** +91 mil	**LP** +129 mil	**LP** +185 mil	**LP** +244 mil	**LP** +333 mil	**LP** +564 mil
2 sócios, com equipe CLT	**S-III** +18 mil	**S-III** +18 mil	**S-III** +10 mil	empate	**LP** +29 mil	**LP** +85 mil	**LP** +156 mil	**LP** +205 mil	**LP** +335 mil

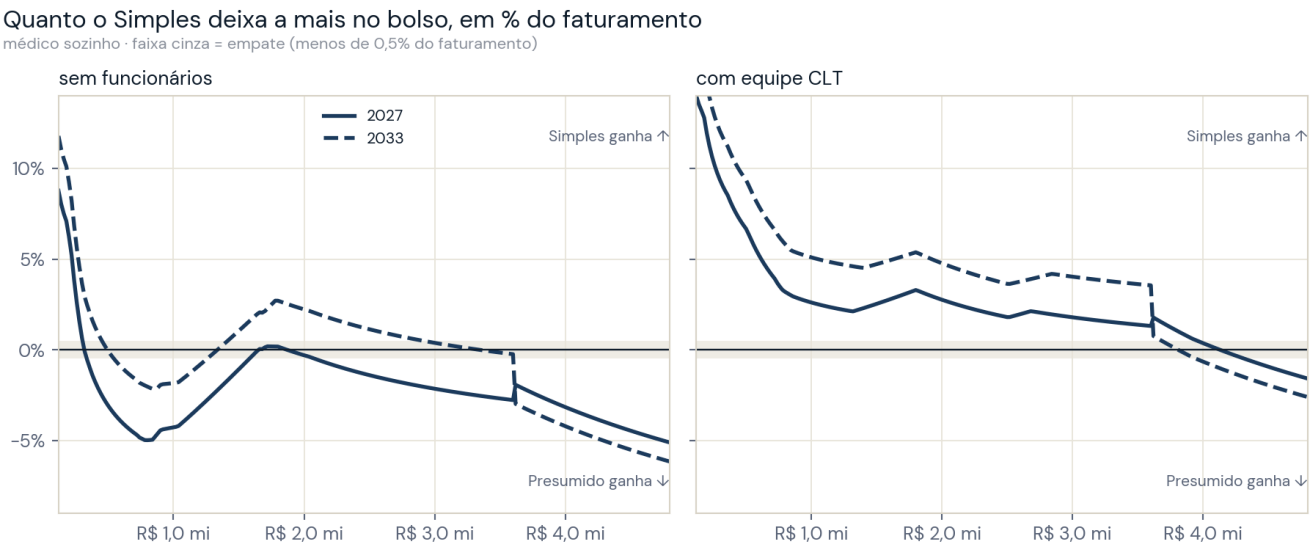
O presumido equiparado passa a ganhar do Simples a partir de R$ 240 mil no médico sozinho e de R$ 660 mil na clínica com equipe. A vantagem chega a R$ 98 mil por ano em R$ 1,2 milhão e a R$ 185 mil em R$ 2,4 milhões. É bem mais que qualquer variação razoável da CBS.

> **QUEM PODE USAR**
>
> A lei exige três coisas: sociedade empresária (sociedade simples e empresário individual ficam de fora), normas da Anvisa cumpridas e serviço da lista. A consulta médica simples fica em 32%, mesmo dentro de hospital. Clínica com receita mista separa cada atividade. Em setembro de 2026 a Receita incluiu a anestesiologia na lista e deixou de excluir quem usa estrutura de terceiros (IN 2.343/2026). Acima de R$ 5 milhões por ano, a LC 224/2025 sobe a presunção em 10% sobre o excedente, e o STF ainda não julgou a ação contra essa regra.

08

Segunda janela: 2033

De 2029 a 2032 o ISS cai um décimo por ano, e o IBS ocupa o lugar dele. Em 2033 o ISS acaba. Para a clínica do presumido em São Paulo, isso troca um ISS de 2% por 12,0% de CBS e IBS por fora. Para o Simples de até R$ 3,6 milhões, nada muda: o IBS entra no DAS no lugar do ISS, com a mesma alíquota total.



Diferença entre o líquido dos sócios no Simples e no presumido, como % do faturamento, para o médico sozinho. Acima de zero, o Simples ganha.

Presunção de 32%, em 2033

Faturamento por ano	R$ 240 mil	R$ 360 mil	R$ 600 mil	R$ 900 mil	R$ 1,2 mi	R$ 1,8 mi	R$ 2,4 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,8 mi
1 sócio, sem funcionários	**S-III** +16 mil	**S-III** +7 mil	**LP** +6 mil	**LP** +17 mil	**LP** +10 mil	**S-III** +49 mil	**S-III** +32 mil	empate	**LP** +296 mil
1 sócio, com equipe CLT	**S-III** +32 mil	**S-III** +40 mil	**S-III** +47 mil	**S-III** +48 mil	**S-III** +57 mil	**S-III** +97 mil	**S-III** +92 mil	**S-III** +128 mil	**LP** +125 mil
2 sócios, sem funcionários	**S-III** +25 mil	**S-III** +27 mil	**S-III** +7 mil	**LP** +15 mil	**LP** +21 mil	**LP** +31 mil	**LP** +48 mil	empate	**LP** +292 mil
2 sócios, com equipe CLT	**S-III** +37 mil	**S-III** +46 mil	**S-III** +58 mil	**S-III** +69 mil	**S-III** +75 mil	**S-III** +84 mil	**S-III** +72 mil	**S-III** +88 mil	**LP** +105 mil

Até R$ 3,6 milhões, a linha tracejada fica acima da cheia: o Simples melhora em relação ao presumido. Com equipe, o Simples passa a ganhar de R$ 120 mil a R$ 3,7 mi, com folga maior que em 2027. Sem funcionários, o presumido só ganha de R$ 560 mil a R$ 1,2 mi e acima de R$ 3,6 mi. Com dois sócios sem equipe, ganha de R$ 740 mil a R$ 3,4 mi e acima de R$ 3,6 mi.

O QUE SOBREVIVE ÀS DUAS JANELAS

A clínica com equipe CLT fica no Simples até R$ 3,9 mi em 2027 e até R$ 3,7 mi em 2033. A clínica de dois sócios sem funcionários fica no presumido a partir de R$ 560 mil em 2027 e de R$ 740 mil em 2033. Já o médico sozinho sem equipe ganha no Simples de R$ 120 mil a R$ 440 mil e de R$ 1,4 mi a R$ 2,9 mi em 2033; em 2027, parte dessa faixa estava no presumido e parte no empate. Para ele, a decisão de hoje tem prazo de validade.

09

Onde este estudo pode estar errado

Médico sozinho, sem funcionários, 2027	R$ 240 mil	R$ 360 mil	R$ 600 mil	R$ 900 mil	R$ 1,2 mi	R$ 1,8 mi	R$ 2,4 mi	R$ 3,6 mi	R$ 4,8 mi
Base do estudo (crédito em 50% das compras, ISS 2%)	**+3,8%**	**-1,0%**	**-4,0%**	**-4,4%**	**-3,2%**	+0,2%	**-1,2%**	**-2,8%**	**-5,1%**
Nenhuma compra gera crédito	**+4,6%**	-0,2%	**-3,2%**	**-3,8%**	**-2,5%**	**+0,9%**	**-0,5%**	**-2,1%**	**-4,4%**
Todas as compras geram crédito	**+3,1%**	**-1,8%**	**-4,7%**	**-5,1%**	**-3,8%**	**-0,5%**	**-1,9%**	**-3,5%**	**-5,8%**
ISS de 5% (fora de São Paulo)	**+6,7%**	**+1,9%**	**-1,1%**	**-1,9%**	**-0,8%**	**+2,8%**	**+1,4%**	-0,2%	**-5,2%**
2033 com IBS de 18,7% (base)	**+6,8%**	**+2,0%**	**-0,9%**	**-1,9%**	**-0,9%**	**+2,7%**	**+1,3%**	-0,2%	**-6,2%**
2033 com IBS de 16,6%	**+6,3%**	**+1,5%**	**-1,5%**	**-2,4%**	**-1,3%**	**+2,2%**	**+0,9%**	**-0,7%**	**-6,1%**

Diferença entre o líquido no Simples e no presumido, como % do faturamento, no médico sozinho sem funcionários. Positivo: o Simples ganha.

1. **"A CBS ainda não é 11,3%."** É verdade. O Senado decide até 15 de dezembro. A tabela da seção 05 mostra que, para o médico sozinho trocar de regime, a CBS cheia teria de passar de 15,0%. Variações de um ou dois pontos não mudam o vencedor.

2. **"Minha clínica quase não tem crédito."** Aluguel pago a pessoa física não gera crédito. Na tabela acima, sem crédito nenhum, a vantagem do presumido cai até 0,8 ponto, e o vencedor só muda nas faixas que já estavam perto do empate.

3. **"Meu ISS não é 2%."** Este é o ponto que mais pesa. Com ISS de 5%, comum fora de São Paulo, o médico sozinho fica melhor no Simples de R$ 120 mil a R$ 440 mil e de R$ 1,4 mi a R$ 2,9 mi, e no presumido, de R$ 540 mil a R$ 1,2 mi e acima de R$ 3,6 mi. Na direção contrária, a sociedade uniprofissional de São Paulo paga ISS fixo por médico, o que deixa o presumido de 2027 mais barato do que aqui. Esse benefício some com o ISS até 2033, e o IBS não tem nada parecido. Na tabela, a linha do ISS de 5% fica perto da linha de 2033: quem paga 5% de ISS já vive em 2027 a conta que São Paulo só verá em 2033.

4. **"O IBS de 2033 é um chute."** É uma projeção. Com 16,6%, que dá alíquota total de 27,9%, o desenho da seção 08 se mantém: o presumido melhora meio ponto, e o vencedor muda só em faixas perto do empate.

5. **"Eu tenho outra renda e dependentes."** Outra renda aumenta a base do IR mínimo e favorece o desenho com mais pró-labore, o Anexo III. Dependentes, previdência e despesas médicas reduzem o IRPF do pró-labore e também favorecem o Anexo III. O estudo usa o caso mais simples, que é conservador contra o Simples.

6. **"O INSS do pró-labore compra aposentadoria."** Sim, e o estudo o conta como custo. No teto, são R$ 11 mil por ano por sócio. Esse valor só mexe nas faixas que já estão no empate.

Ficaram fora o lucro real, que pode compensar em clínica de margem baixa, a receita financeira guardada na empresa e o crédito que a clínica do Simples repassa a clientes empresas. Acima de R$ 3,6 milhões, em 2033, o estudo cobra o DAS sobre o valor cheio, o que pesa contra o Simples. No Fator R, a contribuição patronal de dentro do DAS ficou de fora, o que também pesa contra o Simples.

O QUE SOBREVIVE A TODAS AS OBJEÇÕES

A CBS de 11,3% não decide o regime de nenhuma clínica deste estudo. O que decide é a folha (se há funcionários e quanto o médico precisa tirar de pró-labore), o ISS da cidade e a possibilidade de equiparação hospitalar. Leve esses três números ao contador antes de 2027 e de novo antes de 2029.

10

Base de dados e fontes

Parâmetro	Valor usado	Fonte
CBS de referência 2027	11,3%; cobrada 11,2% + IBS 0,1% em 2027–2028	TCU, 28/10/2026; LC 214 arts. 344, 347, 349
Redução da saúde	60% de CBS e IBS (clínica e serviços médicos)	LC 214 art. 130 e Anexo III
IBS em 2033	18,7% (projeção do CGIBS, sem número oficial)	Res. CGIBS 14
ISS em São Paulo	2% (itens 4.01 e 4.03)	Lei SP 13.701 art. 16
PIS/Cofins até 2026	3,65% cumulativos (só referência)	Leis 9.715 e 9.718
Simples, Anexos III e V	LC 155/2016; 6ª faixa 32,90% e 30,40% em 2027–2028	LC 123; LC 214 art. 519
Fator R	28%; folha = salários + pró-labore + FGTS	LC 123 art. 18 §§5º-J, 5º-M, 24
Sublimite / teto do Simples	R$ 3,6 mi (ISS e IBS saem do DAS) / R$ 4,8 mi	LC 123 arts. 3º e 13-A
Presumido	IRPJ 15% + 10% acima de R$ 60 mil/tri; CSLL 9%; presunção 32%	Lei 9.249 arts. 3º, 15, 20
Equiparação hospitalar	presunção 8% (IRPJ) e 12% (CSLL)	Lei 9.249 art. 15 §1º III a; IN 2.343/2026
INSS sobre pró-labore	20% da empresa (presumido); 11% do sócio até o teto	Lei 8.212 arts. 21, 22, 28
Folha CLT no presumido	20% + RAT 2% + terceiros 5,8%; FGTS 8% nos dois	Lei 8.212 art. 22
Salário mínimo / teto INSS 2026	R$ 1.621,00 / R$ 8.475,55	Decreto 12.797/2025; Portaria MPS/MF 13/2026
IRPF 2026	tabela mensal até 27,5%; desconto até R$ 5.000/R$ 7.350	Leis 15.191 e 15.270
IR mínimo (IRPFM)	renda > R$ 600 mil; até 10% em R$ 1,2 mi; abate IR pago	Lei 9.250 art. 16-A
Redutor	carga PJ + PF acima de 34%	Lei 9.250 art. 16-B
Retenção de dividendos	10% do total acima de R$ 50 mil/mês por empresa	Lei 9.250 art. 6º-A

A base completa tem 8.460 linhas: três janelas (2026, 2027 e 2033), quatro tipos de clínica, faturamentos de R$ 120 mil a R$ 4,8 mi de R$ 20.000 em R$ 20.000 e três regimes. Para cada caso, traz o melhor pró-labore e o imposto separado por tributo. Está no arquivo base_simples_presumido.csv, junto com o motor de cálculo, as premissas e a checagem legal. O simulador_simples_presumido.html refaz a conta para qualquer clínica com o mesmo motor; a paridade entre os dois foi conferida em 624 casos.

1. Lei Complementar 214/2025, compilada com a LC 227/2026 — planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp214compilado.htm
2. TCU calcula alíquota da CBS em 11,3% para 2027. Agência Senado, 28/10/2026 — www12.senado.leg.br/noticias
3. Lei Complementar 123/2006 e anexos da LC 155/2016 — planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
4. Lei 15.270/2025 (arts. 6º-A, 16-A e 16-B da Lei 9.250) — planalto.gov.br
5. Receita Federal, Perguntas e Respostas — Tributação de Altas Rendas, dezembro de 2025
6. Lei 9.249/1995, arts. 3º, 10, 15 e 20; Lei 9.430/1996; IN RFB 1.700/2017, art. 238
7. IN RFB 2.343/2026 (serviços hospitalares) e IN RFB 2.305/2025 (LC 224/2025)
8. Lei 8.212/1991; Decreto 12.797/2025; Portaria Interministerial MPS/MF 13/2026
9. Lei municipal de São Paulo 13.701/2003, arts. 15 e 16
10. Resolução CGSN 194/2026 (opção pelo regime regular de IBS e CBS)
11. Comitê Gestor do IBS, Resolução 14 (projeção de 18,7%)

Aviso importante. Este material tem caráter exclusivamente informativo e educacional e não constitui consultoria tributária, contábil ou jurídica, nem recomendação de investimento, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Os cenários apresentados foram construídos para fins analíticos e não representam a situação de nenhuma clínica ou contribuinte específico. Os resultados decorrem de simulação com premissas declaradas e de normas vigentes em 29/10/2026, algumas ainda sujeitas a regulamentação, a resolução do Senado Federal ou a decisão judicial. A escolha de regime tributário deve ser feita com o contador responsável pela empresa, que conhece os números reais e pode confirmar a interpretação aplicável.

Doctor Invest · Gestão de investimentos e consultoria financeira para médicos · Hélio Cardoso de Barros, CGA · outubro de 2026.